2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Retrato da violência interpessoal/autoprovocada em mulheres no estado do Rio Grande do Sul no ano de 2025

P. B. Markowski[a,*], A. P. A. Aguiar[a], E. M. T. Mota[a], F. A. C. Estrella[a], S. L. Guterres[a,b]

[a]*Universidade Luterana do Brasil (ULBRA), Canoas (RS), Brasil*

[b]*Instituto-Geral de Perícias do RS, Polícia Técnico-Científica, Porto Alegre (RS), Brasil*

**Endereço de e-mail para correspondência: pietramarkowski@gmail.com. Tel.: +55-51-99910-2273.*

Palavras-chave: Violência contra a mulher; Vigilância epidemiológica; Violência interpessoal; Rio Grande do Sul

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, a notificação de violência interpessoal e autoprovocada é obrigatória para todos os serviços de saúde públicos e privados [1]. A notificação deve ocorrer mediante suspeita ou confirmação, sendo essencial para o planejamento de políticas públicas de prevenção, conforme diretrizes da Portaria nº 104/2011 [1]. A finalidade destes registros é produzir dados epidemiológicos (SINAN) e acionar redes de proteção (Conselho Tutelar, Assistência Social, Ministério Público) [2]. Neste trabalho, apresentamos o retrato da violência envolvendo mulheres no Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2025 utilizando a base de dados DATASUS para extração dos dados [3].

No ano de 2025 foram notificados 35.122 casos de violência, destes 25.867 envolveram mulheres o que representa 73,64% [3]. Quando classificadas em raça o predomínio foi da branca com 77,77% seguido da parda com 12,29% [3]. A escolaridade das mulheres foi predominante 18,23% com ensino médio completo, porém como a taxa de ignorados foi muito grande este dado não pode ser analisado de forma confiável [3]. O dado mais significante refere-se ao local da ocorrência da violência, o que apontou a ocorrência na residência da vítima em 78,54%, ou seja, no local onde as vítimas deveriam estar seguras [3]. Na divisão entre violência autoprovocada e interpessoal as taxas foram de 30,80% e 68,41% respectivamente [3]. As violências interpessoais seguiram as ocorrências de física (32,96%), sexual (16,98%), psicológica (13,59%) e tortura (0,09%) [3].

2. OBJETIVO

Analisar os dados de violência interpessoal/provocada em mulheres no Estado do Rio Grande do Sul no ano de 2025, verificando a ocorrência e as características envolvidas na totalidade dos casos.

3. MÉTODOS

Trata-se de um estudo epidemiológico descritivo, de abordagem quantitativa, baseado em dados do Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN), disponibilizado no DATASUS. Foram analisados casos de violência interpessoal e autoprovocada no Rio Grande do Sul no ano de 2025, com foco na violência praticada contra mulheres. As variáveis analisadas incluíram sexo, faixa etária, raça, escolaridade, local de ocorrência e tipo de violência. Por se tratar de dados públicos e sem identificação dos indivíduos, o estudo dispensa aprovação do comitê de ética, sendo consideradas limitações, possíveis falhas no preenchimento de dados e subnotificações.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO

No ano de 2025, obtiveram-se 35.122 casos de violência registrados no Estado do Rio Grande do Sul [1], desse número foram observados que 25.867 foram registros de violência contra a mulher, taxa que representa 73,64% da totalidade dos casos [1],

evidenciando a vulnerabilidade expressiva enfrentada por esse grupo frente a situações de violência, se comparada a vítimas do sexo masculino [2].

Analisando a raça das mulheres envolvidas, 77,77% dessas mulheres eram autodeclaradas brancas [1], seguido por pardas com índices de 12,29% [1], e as demais raças, pretas, amarelas e indígenas, apresentaram menor frequência, perfil justificado pela composição demográfica da região e pelas possíveis desigualdades encontradas, como a possível falta de notificações em ambientes com vulnerabilidade social agravada [2][3].

Referente à escolaridade, 18,23% das mulheres possui Ensino Médio completo [1], no entanto destaca-se a elevada proporção de dados ignorados ou não preenchidos nas fichas, o que limita a confiabilidade da interpretação desses dados [2].

Quanto ao local de ocorrência, comprovou-se que a maioria dos episódios de violência ocorreu na própria residência da vítima [1], achado que demonstra não só que na grande maioria dos casos as mulheres conhecem seus agressores e os mesmos frequentam esse ambiente ou até mesmo dividem a residência. Dessa forma, revela-se que o ambiente doméstico, que deveria representar um lugar de proteção, configura-se como principal cenário de vulnerabilidade [3].

Classificando o tipo de violência, a violência interpessoal foi predominante, representando 68,41% das denúncias [1], enquanto violência autoprovocada corresponde ao número de 30,80% [1]. A alta proporção de casos autoprovocados pode refletir o sofrimento psíquico enfrentado por essas mulheres [3].

Entre as formas de violência interpessoal, a mais praticada foi a violência física com 32,96% dos casos [1], seguida pela violência sexual com 16,98% [1], e violência psicológica 13,59% [1], além de registros de tortura 0,09% [1]. A maior ocorrência de desfechos físicos pode estar associada a maior visibilidade clínica e sintomática dessa forma de agressão, levando a muitos registros de notificação. Desse modo, outras formas de violência, como a psicológica, podem estar sendo subnotificadas, devido a dificuldade de identificação dessa agressão nos sistemas de saúde [2].

Analisando a faixa etária das ocorrências evidenciou-se a maior concentração de casos entre mulheres adultas jovens, especificamente nas faixas de 20 aos 29 anos e 30 aos 39 anos [1], que juntamente refletem uma parcela significativa das notificações. Esse padrão reflete a maior vulnerabilidade dessa faixa etária à exposição à violência, principalmente devido a fatores sociais, econômicos e aos padrões de relações sociais e afetivas [3].

De modo geral, esses resultados demonstram a magnitude dos casos de violência contra a mulher no Estado do Rio Grande do Sul em 2025 [1], caracterizadas principalmente por ocorrência em ambiente doméstico, predominantemente violência interpessoal e física [3]. No entanto, ainda existem limitações quanto a raça e escolaridade, que demonstram limitações na qualidade dos sistemas de informação e na notificação de casos [2].

Tabela 1. Artigos selecionados sobre dados de violência interpessoal/autoprovocada em mulheres.

Artigo	Autores e ano	Conclusão
Sistema de Informação de agravos	BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 104/2011.	Estabelece a notificação compulsória de violências no Brasil, tornando obrigatório o registro desses casos na vigilância epidemiológica.
Sistema de Informação de agravos	BRASIL. Ministério da Saúde. SINAN.	Sistema responsável pelo registro e monitoramento dos casos de agravos de notificação, incluindo violências, permitindo análise do perfil epidemiológico das vítimas no Brasil.
Violência Interpessoal Autoprovocada – Rio Grande do Sul	BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS – TabNet	Ferramenta de acesso público que disponibiliza dados sobre violência interpessoal e autoprovocada, permitindo análise por sexo, idade e localidade.
Subnotificação de violência contra as mulheres: uma análise de duas fontes de dados	Vasconcelos et al. (2024)	Evidencia a subnotificação dos casos de violência contra mulheres no Brasil, indicando discrepâncias entre diferentes sistemas, sendo possível subestimar a real magnitude do problema.
Violence against women prevalence estimates, 2018	World Health Organization (2018)	Aponta que a violência contra a mulher é um problema global de saúde pública, com alta prevalência e impactos significativos na saúde física, mental e social.

5. CONCLUSÃO

Os dados demonstram que a violência contra a mulher no Rio Grande do Sul em 2025 representa um problema relevante de saúde pública [3], com grande predominância de casos envolvendo vítimas do sexo feminino [1]. Observa-se maior ocorrência no ambiente doméstico [1], o que mostra que muitas situações de violência acontecem em cenários de convivência próxima com o agressor, sendo esse um

padrão amplamente descrito na literatura [3]. A violência interpessoal foi a mais frequente [1], com destaque para a forma física, seguida das violências sexual e psicológica [1][3].

Além disso, notou-se maior concentração de casos entre mulheres adultas jovens [1], indicando maior vulnerabilidade nessa faixa etária, conforme apontado em estudos epidemiológicos [3]. A presença expressiva de violência autoprovocada [1] aponta para possíveis impactos na saúde mental dessas mulheres [3].

Por outro lado, limitações nos dados, especialmente o alto número de informações ignoradas, dificultam análises mais detalhadas, principalmente no que diz respeito à escolaridade e raça, refletindo problemas já descritos na literatura quanto à subnotificação e à qualidade do preenchimento das fichas [2]. Diante disso, fica evidente a necessidade de melhorar o preenchimento das notificações e ampliar as ações de prevenção e cuidado, com atuação conjunta dos serviços de saúde e da rede de apoio [2][3].

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

[1] BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 104, de 25 de janeiro de 2011. [s.l: s.n.]. Disponível em: https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/gm/2011/prt0104_25_01_2011.html. Acesso em: 30 de mar. 2026.

[2] BRASIL. Ministério da Saúde. Sistema de Informação de Agravos de Notificação (SINAN). [s.l: s.n.]. Disponível em: https://datasus.saude.gov.br/. Acesso em: 30 de mar. 2026.

[3] BRASIL. Ministério da Saúde. DATASUS – TabNet (Violência interpessoal e autoprovocada). [s.l: s.n.]. Disponível em: http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/tabcgi.exe?sinannet/cnv/violers.def. Acesso em: 30 de mar. 2026.

[4] VASCONCELOS, Nádia Machado de et al. Subnotificação de violência contra as mulheres: uma análise de duas fontes de dados. Ciência & Saúde Coletiva, v. 29, n. 10, e07732023, 2024. Disponível em: https://doi.org/10.1590/1413-812320242910.07732023. Acesso em: 23 abr. 2026.

[5] WORLD HEALTH ORGANIZATION. Violence against women prevalence estimates, 2018. [s.l: s.n.]. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256. Acesso em: 30 de mar. 2026.

[6] BRASIL. Conselho Nacional de Saúde. Resolução nº 510, de 7 de abril de 2016. [s.l: s.n.]. Disponível em: https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf. Acesso em: 30 de mar. 2026.

[7] WORLD HEALTH ORGANIZATION. Violence against women prevalence estimates, 2018. [s.l: s.n.]. Disponível em: https://www.who.int/publications/i/item/9789240022256. Acesso em: 30 de mar. 2026.